EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 67013
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-07-06 13:20:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS ALBERTO VALLADARES LOPEZ			RUN	: 6.807.796-6
F.Nac	: 07-11-1950	Edad	: 72 AÑOS, 7 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: Brasil 1201			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-06-28	Fecha Egreso	: 2023-07-06 13:20:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

NEUMONIA POR PSEUDOMONA AERUGINOSA Y S. AUREUS MULTIRESISTENTE
RESECCIÓN DE CRANEOFARINGIOMA (TUMOR BENIGNO DE LA HIPOFISIS)
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
DIABETES MELLITUS TIPO 2
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA
HIPOKALEMIA EN RESOLUCION
HIPOTIROIDISMO
PARÁLISIS FACIAL
POSTRADO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18-NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes descritos dado de alta el 21 de junio por larga hospitalizado por neumonia intrahospitalaria. Consulta el 24 de junio por sintomas de itu y se inicia tto con ertapenem 1 gramo al dia, es evaluado en HODOM, se pesquisa paciente en muy mal estado general, soporoso, gran cantidad de ruidos bronquiales por lo que se deriva. Cultivos tomados el 24 de junio aspirado traqueal y urocultivo + para pseudomona aeruginosa, por lo que se inicia traslape de antibioticoterapia a ceftazidima. (completa 7 dias, asociada a cotrimoxazol forte))
Paciente mejor, CLOTE, tranquilo y cooperador, responde ok, y sigue ordenes . Afebril desde su ingreso. Asintomatico.
HDE. Se desteta de O2 Con buena tolerancia
Mejor toleracia a kine y fono, con alimentacion mixta por Fono, se retiro SNG el 05/07 tolerando regimen vo, liviano chancado
Ex lab: Crea 0.8/ Pcr 5.2/ NA 144, K 2.9 , CL 113 / LEUCO 12600, HB 10.8, HTO 32.3, PLAQ 540000
Se realiza correccion de hipokalemia con carga de potasio con regular respuesta
Hemocultivos (2) Rescatados (24/07): NEGATIVOS

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO SEMISENTADO, ASISTIDO, PREVENCION UPP, CONTENCION SOS
2. REGIMEN HIPOSODICO PARA DIABETICOS, ASISTIDO FONO Y FAMILIARES, MAS SUPLEMENTOS POR NUTRICIONISTA
3. SEGUIMIENTO POR FONO

4. OPTIMiZAR KNT RESPIRATORIA Y MOTORA 2 VECES AL DIA
5. CURACIONES UPP SACRA
6. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
7. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
8. ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
9. IPRATROPIO INHALADOR FRASCO UNIDAD 2PUFF C8H AEROCAMARA
10. ZOLPIDEN COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 20 dias via ORAL, NOCHE
11. FLUOXETINA COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
12. HEPARINA SODICA 5000 U.I AMPOLLA 1 MILÍMETRO 1 ampolla cada 12 hrs. por 20 dias via SUBCUTANEA
13. FLUTICASONA/SALMETEROL INHALADOR 250 MICROGRAMOS / 25 MICROGRAMOS 4 puff cada 12 H CON AEROCAMARA
14. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 2 comprimido cada 8 hrs. por 5 dias via ORAL, SOS SI DOLOR
15. POTASIO CLORURO COMPRIMIDO 600 MILÍGRAMOS 2 comprimido cada 8 hrs. por 6 dias via ORAL
16. APETROL 5 ML POR 2 VECES AL DIA VO (ANTES DE LAS COMIDAS)
17. CONTROL POST ALTA HODOM POLI MED INTERNA LUEGO DE 20 A 30 DIAS

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO